

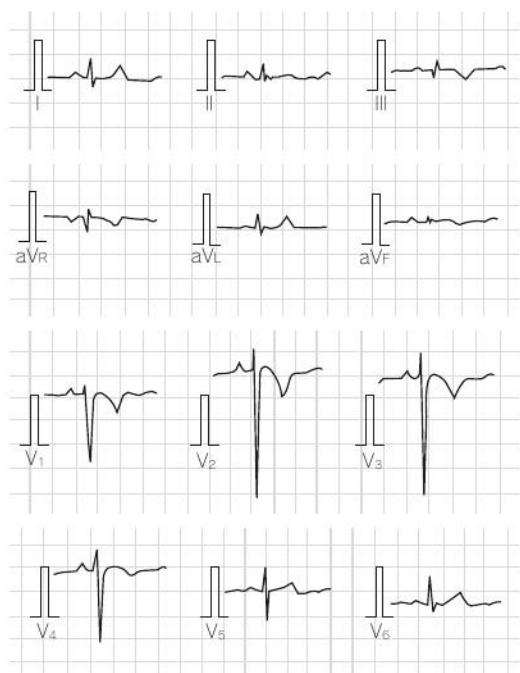


図2 急性肺血栓塞栓症症例の心電図

肺性 P 波、I 誘導 S 波、III 誘導 Q 波、T 波陰転化 (S_IQ_{III}T_{III}) が認められる。

性心疾患や肺静脈還流異常、三尖弁閉鎖不全症などで生じる。圧負荷型右室肥大の終末像でも同様の所見を呈する。V₁、V₂のQRS波は不完全右脚ブロック型が特徴的であり、圧負荷型と同様にV₅、V₆の深いS波を認める。

4 呼吸器疾患が心電図所見に及ぼす影響

COPDなど肺の過膨張を伴う疾患、結核性収縮性心膜炎、右心不全による心嚢液貯留などの病態においては低電位を認める場合が多く、特徴的所見を把握しがたい。特に、過膨張を伴う疾患では、横隔膜低位のために右前胸部誘導におけるR波の増高が不良となる。強い時計回り回転を呈し、V₁-V₄でQSパターンを呈することがあり、しばしば前壁中隔心筋梗塞との鑑別を必要とする。

文 献

- 1) 伊藤 浩ほか：肺高血圧症診療マニュアル，南江堂，p36，2012
- 2) 安田正之ほか：診断と治療 94：175，2006